

Hôpital de Chandler

Réfection de l'enveloppe

Rapports d'analyse du dossier d'appel d'offres et du phasage — version lisible

Version du 5 octobre 2026. Document de travail, non contractuel. Chaque rapport reprend en prose la version de référence du même numéro, qui reste la source pour toute citation, tout tableau complet et toute annexe. Les marqueurs [lecture], [choix] et [à confirmer] distinguent ce qui est lu sur un plan, ce que GLCRM propose et ce que les documents ne fixent pas.

Les cinq rapports

01 — Ce que contient le dossier d'appel d'offres

Le dossier compte onze documents répartis en cinquante fichiers, et il est complet pour l'essentiel. Trois choses pèsent pourtant sur le phasage avant même de lire une contrainte : la procédure de prévention des infections jointe au dossier est celle d'un autre CISSS, le tableau de coordination des équipements électromécaniques annoncé dans les plans n'y est pas (seule une version préliminaire de mai existe), et le contrat fixe des dates de travaux antérieures à l'émission des plans et devis.

02 — Les contraintes : ce que les documents imposent, où ils se contredisent, ce qu'ils laissent

Les onze documents imposent 719 contraintes écrites, se contredisent en quarante points et laissent vingt-neuf questions sans réponse. Trois lacunes dominent toutes les autres : aucun document ne fixe l'horaire de travail, le régime de prévention des infections applicable à Chandler n'est pas dans le dossier, et le phasage est attribué à la fois à l'entrepreneur, aux architectes et au CISSS.

03 — Le plan de phasage proposé

Le phasage proposé suit l'ordre du plan clé des architectes — préalables, basilaire est, tour, basilaires nord, ouest et sud, clôture —, mais presque rien de cet ordre n'est écrit. Une douzaine de séquences seulement sont imposées par un texte ; tout le reste est une lecture des plans ou un choix d'ordonnancement, présenté comme tel avec ses variantes. Sept conflits ne peuvent pas être tranchés à partir des documents et attendent une décision des architectes, de WSP ou du CISSS.

04 — La vérification adverse du phasage

Le plan de phasage a été relu contre le registre par trois vérificateurs qui ne l'avaient pas rédigé : les 719 contraintes y sont toutes traitées, une seule violation a été trouvée et corrigée, et 38 affirmations qui n'étaient pas sourcées ou qui faisaient dire à une contrainte plus qu'elle ne dit ont été corrigées ou signalées. Plus rien dans le phasage ne prescrit ce que le registre interdit. Ce qui reste ouvert, ce sont neuf décisions qui appartiennent aux émetteurs des documents.

05 — Le phasage lu sur les élévations

Lu façade par façade, le phasage change de nature : ce n'est plus l'architecture qui ordonne les travaux, c'est l'électromécanique. Les seules dépendances écrites entre façades viennent des appareils qu'il faut déplacer ou maintenir en fonction avant de démolir un parement, et la façade nord ne peut pas être traitée d'un seul tenant parce que son propre tableau exige l'été pour une intervention et l'exclut pour deux autres. Rien de cela n'était visible dans la vue en plan.

01 — Ce que contient le dossier d'appel d'offres

Hôpital de Chandler, réfection de l'enveloppe · CISSS de la Gaspésie · AOC-077221 · dossier GLCRM R-657-24
Version lisible du 5 octobre 2026. Le détail — fiche projet, index des pages, tableaux complets — reste dans la version de référence (01-inventaire).

Le dossier compte onze documents répartis en cinquante fichiers, et il est complet pour l'essentiel. Trois choses pèsent pourtant sur le phasage avant même de lire une contrainte : la procédure de prévention des infections jointe au dossier est celle d'un autre CISSS, le tableau de coordination des équipements électromécaniques annoncé dans les plans n'y est pas (seule une version préliminaire de mai existe), et le contrat fixe des dates de travaux antérieures à l'émission des plans et devis.

Les onze documents

Les codes D1 à D11 servent dans tous les rapports qui suivent.

Code	Document	Émetteur	Émission	Pages
D1	Devis d'architecture	GLCRM Proulx Savard	Pour appel d'offres, 4 septembre 2026	585
D2	Plans d'architecture	GLCRM Proulx Savard	Définitifs pour soumission, 4 septembre 2026	78 feuilles
D3	Devis de mécanique-électricité	WSP	Définitifs pour soumission, 4 septembre 2026	231
D4	Plans de mécanique-électricité	WSP	4 septembre 2026	23 feuilles
D5	Tableau de coordination des équipements électromécaniques	WSP	11 mai 2026	8
D6	Plans de structure	WSP	4 septembre 2026	22 feuilles
D7	Porte-documents de structure (même jeu que D6)	WSP	8 septembre 2026	—
D8	Contrat de l'appel d'offres	Santé Québec – CISSS de la Gaspésie	Imprimé le 13 avril 2026	104
D9	Régie de l'appel d'offres	Santé Québec – CISSS de la Gaspésie	Imprimé le 13 avril 2026	37
D10	Procédure PCI pour les travaux	CISSS de Chaudière-Appalaches	En vigueur depuis le 9 juin 2017	24
D11	Tableau des contraintes opérationnelles de l'établissement, v3	CISSS de la Gaspésie	Modifié le 1er septembre 2026	1 feuille

Le contrat et la régie sont des documents numérisés : leur texte a été obtenu par reconnaissance de caractères, et chaque citation retenue a été vérifiée sur l'image de la page. Le texte des plans d'architecture n'est pas exploitable directement ; toutes les citations des plans viennent d'une lecture sur rendu image.

Ce que chaque corpus apporte

L'architecture porte l'essentiel des exigences d'exécution. Le devis (D1) compte 53 sections, dont quatorze encadrent directement le séquençement et l'exploitation de l'hôpital, notamment les restrictions visant les travaux (01 14 00), ordonnancement (01 32 16.19), santé-sécurité (01 35 29), qualité de l'air (01 35 46), installations et protections temporaires (01 51 00, 01 52 00, 01 56 00), prévention des infections (01 56 50), démolition sélective (02 41 19.13), matières dangereuses (02 81 00), coupe-feu (07 84 00) et volets coupe-feu (08 33 23). Le devis ne fixe toutefois ni zones, ni phases, ni dates : il renvoie l'ordonnancement aux feuilles 002, 010 et 011 des plans et aux contraintes émises par le CISSS, et précise que les documents contractuels décrivent « une hypothèse de séquence générale de travaux », non un phasage détaillé.

Les plans (D2) contiennent le seul phasage global du dossier : le plan clé de la feuille 010 découpe le bâtiment en trois phases par secteur — basilaire est, tour, basilaires nord, ouest et sud — avec des durées indicatives de ± 5 , ± 8 et ± 4 mois. L'attribution des zones A à L aux phases n'y est que graphique, par couleurs, et le cadre « Notes » de la feuille est vide. La feuille 002 détaille la gestion du chantier, dont les configurations successives de l'entrée des ambulances (deux) et de l'entrée principale (trois). Les feuilles 501 à 505 fixent le principe de remplacement des fenêtres : prototype en présence de l'architecte, plexiglas dès le retrait, bâti isolé de novembre à avril, thermos et finition le même jour.

L'électromécanique (WSP) renvoie le phasage, les horaires, les percements et la prévention des infections aux documents d'architecture et du propriétaire ; son devis (D3) n'a aucune prescription PCI propre, mais impose le maintien en tout temps des services de mécanique et d'électricité. Ce sont les plans (D4) qui portent les séquences imposées : conduits temporaires pour garder la prise d'air du bloc opératoire en fonction, événements des autoclaves à relocaliser avant la façade ouest, prise d'air médical temporaire sur la façade ouest pendant les travaux de la façade nord, conduits temporaires de l'hémodialyse avant la démolition. Le tableau de coordination (D5) est le seul document du dossier qui chiffre des durées et des fenêtres de coupure (« 2 X 2h », « Nuit ou le matin avant 10h », « Dimanche seulement, en dehors de la période estivale »).

La structure (WSP) ne découpe rien géographiquement : elle confie la séquence de construction et de démolition à l'entrepreneur, sous ingénierie scellée. Elle impose en revanche un enchaînement par façade — démolition, relevé complet, coordination de l'alignement avec l'architecte, fabrication — et un point d'arrêt après le retrait des revêtements. Ses plans portent la mention « ne doit pas être utilisé à des fins de construction » : une émission pour construction est un préalable au chantier.

Les documents du CISSS sont les plus minces sur l'exécution. Le contrat (D8) fixe les dates — début le 31 août 2026, fin le 31 décembre 2027 — et exige un échéancier exposant le phasage, mais ne contient ni horaire de travail, ni préavis d'interruption, ni pénalité chiffrée, ni annexe PCI. La régie (D9) encadre l'appel d'offres lui-même et déclare n'avoir « aucune disposition particulière ». Le tableau des contraintes

(D11) découpe les travaux par niveau, avec une classe PCI et un horaire codé « J », « S » ou « J/S » pour une partie des lignes, sans légende ; neuf de ses colonnes ne sont jamais remplies, dont la restriction saisonnière et l'accès au chantier.

Les trous et les incohérences

Des documents annoncés manquent. La feuille G003 « Tableau de coordination des équipements électromécaniques » est listée « à venir » dans les plans de WSP et absente du jeu ; le tableau D5 du 11 mai en est vraisemblablement la version préliminaire, mais aucun texte ne le dit, et il n'a pas été mis à jour aux émissions d'août et de septembre. La feuille S001 « Plan d'implantation » de structure est listée et absente, tandis que S402 est présente sans être listée. Il n'existe aucun devis de structure, alors que les notes générales y renvoient cinq fois. Le devis d'architecture cite des sections qui n'existent pas, dont 01 35 21, bloquante pour l'examen des dessins d'atelier, et des documents non joints : devis de mise en service, annexes J et DA.7, rapports d'expertise en matières dangereuses.

La procédure PCI n'est pas celle du bon établissement. Le devis exige le respect de la procédure PCI « du CISSSGA », qui a préséance sur sa propre section 01 56 50. La seule procédure du dossier est celle du CISSS de Chaudière-Appalaches, entrée en vigueur en 2017, qui ne mentionne ni la Gaspésie, ni Chandler, ni l'appel d'offres. Le contrat ne contient aucune procédure PCI et le tableau du CISSS renvoie à « la procédure PCI des Conditions générales ». Le régime PCI applicable à Chandler n'est donc établi par aucun document.

Les dates ne se tiennent pas. Le contrat et la régie sont imprimés le 13 avril 2026 avec un calendrier d'appel d'offres de juin-juillet 2026 et un début des travaux au 31 août 2026, alors que les plans et devis sont émis pour soumission le 4 septembre 2026. Ce sont vraisemblablement les documents d'un lancement antérieur ou reporté ; leurs délais ne peuvent pas servir tels quels. Le calendrier de travail retenu par GLCRM — installation de chantier en novembre 2026, travaux de janvier 2027 à décembre 2028 — est donc celui des rapports suivants, à confirmer avec le CISSS.

Le statut contractuel des documents n'est pas fixé. L'annexe « Plans et devis » du contrat, à laquelle renvoie la définition même des plans et devis, porte « a) à compléter ». Rien ne dit donc si le tableau D5, la procédure PCI ou le tableau du CISSS sont contractuels.

Le reste relève de la mise au propre. WSP cite le numéro de dossier R674-24 au lieu de R657-24 ; l'adresse s'écrit « 451 rue Mgr-Ross » chez les uns et « 451 rue Ross Est » chez les autres ; les données climatiques de structure sont celles de Percé ; le contrat contient des renvois internes erronés et une phrase incomplète à l'article 10.08.04 sur le suivi de l'échéancier ; il évoque une « clause pénale prévue au Contrat » qui n'y figure pas. Les plans de structure laissent en blanc les charges des pieux de l'escalier no 7.

Ce que ça implique pour la suite

Le phasage repose sur trois sources qui ne se répondent pas : le plan clé des architectes, le tableau par niveau du CISSS et les séquences électromécaniques de WSP. Aucune n'est complète, et deux d'entre elles — le tableau D5 et la procédure PCI — ont un statut incertain. Les rapports qui suivent citent donc

chaque contrainte avec sa source exacte, distinguent ce qui est écrit de ce qui est lu sur un plan, et signalent ce qu'il faut faire confirmer plutôt que de le supposer.

Plusieurs fichiers contiennent des noms et coordonnées de personnes ; ils ne sont reproduits dans aucun des rapports.

02 — Les contraintes : ce que les documents imposent, où ils se contredisent, ce qu'ils taisent

Hôpital de Chandler, réfection de l'enveloppe · CISSS de la Gaspésie · AOC-077221 · dossier GLCRM R-657-24
Version lisible du 5 octobre 2026. Le registre lui-même — 719 lignes citées mot à mot avec leur source — reste dans la version de référence (02-contraintes), qui est celle à consulter pour toute citation.

Les onze documents imposent 719 contraintes écrites, se contredisent en quarante points et laissent vingt-neuf questions sans réponse. Trois lacunes dominent toutes les autres : aucun document ne fixe l'horaire de travail, le régime de prévention des infections applicable à Chandler n'est pas dans le dossier, et le phasage est attribué à la fois à l'entrepreneur, aux architectes et au CISSS.

Comment le registre est construit

Une contrainte n'y entre que si elle est écrite ; ce qui est implicite est consigné à part, comme zone d'ombre, sans qu'aucune contrainte en soit déduite. Chaque ligne cite le passage entre guillemets avec sa source précise — document, section et article, ou feuille et numéro de note, et page.

Les 719 lignes se répartissent ainsi : 353 viennent du devis d'architecture (AR-DEV), 82 des plans d'architecture (AR-PLN), 161 de l'électromécanique (ME), 40 de la structure (ST), 30 du tableau des contraintes du CISSS (CI-TAB), 26 de la procédure PCI (CI-PCI) et 27 du contrat (CI-CTR). Chacune est classée selon ce qu'elle impose : un préalable à respecter avant une activité, une interdiction ou une obligation de maintien en tout temps, une fenêtre horaire ou saisonnière, ou un préavis. Les préalables sont de loin les plus nombreux.

Les contradictions entre documents

Le contrat donne une règle de primauté — addenda, puis contrat, devis, plans et dessins — et plusieurs documents prévoient que l'exigence la plus stricte l'emporte. Ces règles ne suffisent pas à trancher les contradictions qui suivent : la plupart opposent des textes de même rang, ou un texte à un document absent.

Prévention des infections

Le devis exige le respect de la procédure PCI « du CISSSGA », qui a préséance sur sa propre section ; la seule procédure du dossier est celle du CISSS de Chaudière-Appalaches, de 2017, et le contrat n'en contient aucune (**C-01**). C'est la contradiction de fond : tout ce qui suit sur les classes et les mesures dépend d'une procédure dont l'applicabilité n'est pas établie.

Le tableau du CISSS attribue à six de ses lignes une classe inférieure à celle que donne la matrice de cette procédure — classe I au lieu de III, III au lieu de IV — ce qui fait l'économie, en classe IV, du sas et des vêtements de protection (**C-02**). À l'inverse, il exige un sas en classe II, où la procédure déclare qu'« aucun SAS n'est requis » (**C-03**).

Sur les mesures elles-mêmes, le devis et la procédure visent la même pression négative de 7,5 Pa, mais le devis admet une tolérance de quatre heures par vingt-quatre heures que la procédure ignore (C-04). Le devis exige une séparation coupe-feu d'une heure, continue jusqu'à la dalle, entre la zone de travaux et les secteurs occupés, tout en admettant des écrans de polyéthylène pour les interventions de très courte durée (C-05). Il interdit d'utiliser la ventilation du bâtiment pendant les travaux, alors que l'hôpital reste en exploitation et que plusieurs systèmes doivent rester en fonction toute la durée du chantier (C-06). Le nettoyage est exigé tantôt en fin de quart, tantôt en fin de journée, ce qui diverge dès qu'il y a des quarts de soir (C-07).

Horaires, accès et préavis

Aucun document ne fixe la plage horaire de travail : le devis renvoie au contrat, qui n'en dit rien, et le tableau du CISSS utilise des codes « J », « S » et « J/S » sans légende (C-08). Les fragments d'horaire qui existent sont éparés et ne se raccordent pas : livraisons entre 9 h et 15 h, transports hors norme avant 7 h, travaux bruyants en soirée, percements « en dehors des heures d'occupation », débris hors des « heures de grands achalandages » — aucune de ces notions n'est définie (C-09).

L'accès au chantier suit trois régimes différents selon le passage : par l'entrée principale seulement, par des barrières multiples, ou directement de l'extérieur, qui est à prioriser (C-10). Le seul préavis de coupure de service écrit est de 48 heures, au devis d'architecture ; le devis de WSP n'en chiffre aucun et le délai de « 2 jrs » du tableau du CISSS n'est pas raccordé (C-11). Les travaux à chaud connaissent trois durées de surveillance et trois régimes de permis, par site, par quart ou par secteur (C-12).

Phasage et calendrier

Le phasage relève, selon le passage, de l'entrepreneur (« seul responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences »), des documents d'architecture (« ces phases sont décrites aux documents d'architecture ») ou du CISSS, qui émet les contraintes d'ordonnancement opérationnelles et doit approuver un échéancier « préétabli » (C-13).

Le contrat fixe le début des travaux au 31 août 2026 et la fin au 31 décembre 2027, alors que les plans et devis sont émis pour soumission le 4 septembre 2026 ; avec les délais préalables du contrat — garanties, assurances, autorisation de débuter —, ces dates sont inapplicables en l'état (C-14). GLCRM travaille avec un calendrier différent : installation de chantier en novembre 2026, travaux de janvier 2027 à décembre 2028, à confirmer avec le CISSS.

Le même calendrier initial est exigé dans cinq délais différents, de cinq jours ouvrables après l'attribution à « la première assemblée de chantier » (C-15). Le contrat invoque une clause pénale qui n'y figure nulle part (C-16), et son article sur le suivi bimensuel de l'échéancier contient une phrase incomplète, alors que le devis exige une planification hebdomadaire remise le jeudi matin (C-17).

Interfaces entre disciplines

Le devis de WSP confie la coordination des parcours de conduits à l'entrepreneur général dans une section et à l'entrepreneur en ventilation dans une autre (C-18). Un percement de structure doit être approuvé par le professionnel et le CISSS selon le devis d'architecture, par l'ingénieur en structure selon

WSP, et annoncé à l'organisme public selon le contrat — quatre interlocuteurs que rien ne hiérarchise (C-19).

Les plans de structure renvoient, pour les échafaudages, à des charges de neige « indiquées au plan clé » qui n'y sont pas, et la feuille S303 ajoute une interdiction de charge ponctuelle sur les toitures ventilées qu'on ne trouve nulle part ailleurs (C-20). Les essais d'étanchéité de l'enveloppe sont gérés et financés par l'entrepreneur pour le pare-air, par le CISSS pour les fenêtres et les murs-rideaux — pour des systèmes dont les jonctions sont justement ce qu'on teste (C-21). L'agent de mise en service est à nommer par l'entrepreneur, alors qu'une firme est déjà désignée ailleurs dans le devis (C-22). Le devis de WSP cite des éditions de codes différentes d'une section à l'autre, chacune se déclarant prévalente (C-23), et deux règles différentes pour résoudre une contradiction entre plans et devis (C-24).

Cohérence documentaire

Ces neuf points relèvent de la mise au propre plus que du phasage : numéro de dossier R674-24 au lieu de R657-24 chez WSP (C-25) ; désignation du donneur d'ouvrage et adresse variables (C-26) ; feuilles listées mais absentes, ou présentes mais non listées, en électromécanique comme en structure (C-27) ; renvois internes erronés, à lire par leur contenu plutôt que par leur numéro (C-28) ; sections citées qui n'existent pas, dont 01 35 21, bloquante pour les dessins d'atelier (C-29) ; incohérences internes au tableau du CISSS, dont la sous-phase « A.6 » attribuée à cinq activités sur trois niveaux (C-30) ; identifiants en double dans le tableau D5 (C-31) ; gabarits non harmonisés dans le devis d'architecture, dont une section sur les bonnes pratiques de fabrication héritée d'un autre projet (C-32) ; numérotation tronquée et données climatiques de Percé sur la feuille S002 (C-33).

Plans d'architecture

Trois numérotations « phase 1, 2, 3 » coexistent sans lien écrit : les phases par secteur du plan clé de la feuille 010, les configurations successives des ambulances et de l'entrée principale de la feuille 002, et la phase unique du tableau du CISSS avec ses sous-phases par niveau (C-34). C'est le nœud de tout le phasage. Le plan clé est le seul phasage global écrit, et la répartition de ses phases par zone n'est donnée que par les couleurs, sans aucune phrase de la forme « phase 1 = zones D, E, F » (C-35).

Les fenêtres se remplacent en deux étapes selon le titre de la feuille 505 et en trois selon son détail B et la feuille 503, et le vocabulaire du CISSS — plexiglas, thermos, cadrage et toile — n'est pas celui des plans, extérieur et intérieur (C-36). Les titres de plusieurs feuilles diffèrent entre la liste des plans et le cartouche (C-37). La clôture plus haute près du nouvel escalier no 7 n'apparaît que sur la feuille 001 (C-38). Aucune des 79 feuilles d'architecture ne chiffre un degré de résistance au feu : tout dépend des devis (C-39). Enfin, le secteur des archives est « non touché par les travaux » au plan clé alors que le tableau du CISSS et les plans de WSP y placent des renforts de structure en classe IV dans l'entreplafond du local R-22 : « non touché » vaut pour l'enveloppe, pas pour l'intérieur (C-40).

Les zones d'ombre

Ce sont les questions auxquelles aucun document ne répond, ou que les documents renvoient à un texte absent. Aucune contrainte n'en est tirée : elles appellent une réponse des émetteurs.

Le temps

L'horaire de travail n'est défini nulle part — ni heures de début et de fin, ni régime du soir, de la nuit et des fins de semaine (**Z-01**). Le délai de « 2 jrs » du tableau du CISSS peut être un préavis, une durée de libération du local ou un délai de réactivation ; rien ne le dit (**Z-03**).

Les contraintes saisonnières sont éclatées (**Z-10**). Les seuils de température existent matériau par matériau — béton, maçonnerie, couverture, scellants, peinture, vitrage — mais aucune fenêtre saisonnière d'ouverture de l'enveloppe n'est fixée, et la colonne « Restriction saisonnière » du tableau du CISSS renvoie à un onglet des ingénieurs qui n'existe pas. Le tableau D5 porte huit lignes bornées par une saison : deux exigent l'été (N-F-E-008, O-B-V-004), quatre l'excluent (N-F-V-005, N-F-P-002, E-G-V-003, E-G-E-006), une se contredit (S-A-V-001, « en dehors de la période estivale (quelques jours en été) ») et une exclut l'hiver (O-B-E-001). GLCRM retient comme définition de travail une période estivale de la mi-juin à la mi-août, approximativement du 24 juin au 15 août ; avec le calendrier de travaux de janvier 2027 à décembre 2028, cela ouvre deux fenêtres estivales, en 2027 et en 2028. Les deux données sont à confirmer avec le CISSS.

L'ordre des phases n'est écrit nulle part : ni 1 → 2 → 3, ni la possibilité de les mener en parallèle, ni le lien avec les saisons (**Z-23**).

L'espace et le découpage

Il manque une table de correspondance entre les systèmes de désignation : zones A à L des architectes, secteurs et locaux du CISSS, secteurs de structure nommés par année de construction, élévations A à I de WSP (**Z-02**, **Z-24**). La lecture par élévation du 17 septembre en a tranché une partie : les titres des dessins écrivent la façade de chaque repère, et le tableau D5 indexe ses 93 lignes par façade et par élévation. Le repère C est une élévation ouest partielle, D une élévation est partielle, H une élévation est partielle — et non nord, comme le plan clé de la feuille 011 le laissait lire —, et deux repères absents du cahier en plan existent, J au sud et K à l'ouest.

Ni grue, ni échafaudage, ni aire de levage ne sont implantés sur les plans d'architecture (**Z-27**), et la signification des capacités de toiture inscrites sur la feuille S200 — cinq valeurs en kN/m² sans légende — n'est pas donnée (**Z-11**). L'étendue des secteurs « hors contrat » repérés six fois sur les plans de structure n'est pas nommée (**Z-21**). L'usage des locaux R22-A à R22-D, où se font des renforts de structure en classe IV, n'est pas écrit (**Z-25**).

L'hôpital en exploitation

Le régime PCI applicable à Chandler, la liste des locaux par groupe de risque et le statut contractuel de la procédure et du tableau du CISSS sont absents (**Z-05**). Les documents disent qu'il faut garder certains systèmes en fonction en tout temps — prise d'air du bloc opératoire, air médical, événements d'autoclave, caméra de l'urgence, hémodialyse — mais aucun ne dresse la liste consolidée des services dont toute interruption est interdite, ni de plan de contingence (**Z-06**). La mise hors service d'une zone de gicleurs est prévue au quai des ambulances, sans mesures compensatoires écrites (**Z-08**) ; rien n'encadre la génératrice, le délestage ou les essais de l'alimentation d'urgence (**Z-09**).

Côté occupants, rien ne dit combien de temps un local occupé peut rester sans fenêtre définitive, ni qui libère les locaux, ni comment s'articulent les trois étapes du CISSS avec les deux ou trois étapes des plans (Z-07). Certaines fenêtres sont exclues du principe en étapes sans méthode de remplacement, et les fenêtres de la cage d'escalier no 3, qui reste une issue, sont à obturer sans protection temporaire décrite (Z-26). Qui déplace les patients, le mobilier et le matériel médical, quand et à quels frais n'est écrit nulle part (Z-14). L'ascenseur no 1 et l'escalier « le plus près du chantier » sont désignés « à confirmer » (Z-15).

La nouvelle issue extérieure permanente est annoncée au devis, aux plans de WSP et au tableau du CISSS ; l'escalier no 7 des plans de structure est vraisemblablement cette issue, mais le mot « issue » n'apparaît sur aucune feuille de structure, et rien ne dit si elle doit être en service avant qu'une issue existante soit condamnée (Z-12). Les renforts structuraux intérieurs ne sont pas situés par rapport à la démolition des façades (Z-13). Les seuils de bruit et de vibration seront « établis dès le début avec le CISSSGA » : aucune valeur n'est donnée (Z-04).

Les documents et les décisions en suspens

La liste contractuelle des plans et devis est « à compléter » au contrat, et plusieurs documents cités sont absents (Z-16). Le tableau D5 contient des questions restées ouvertes au 11 mai — « Usage?? », « À valider ? », bonbonnes d'air médical « à acheter par CISSS ou temporaires par entrepreneur ? » (Z-17). Le paratonnerre n'a qu'une feuille de démolition, sans système neuf (Z-18). La liste des espaces clos est un gabarit vide (Z-19). Aucun document ne mentionne d'aire d'atterrissage d'hélicoptère ; l'existence d'une hélisurface à l'hôpital n'a pas été vérifiée et reste à confirmer avec le CISSS (Z-20). Le régime d'enquête et de badges renvoie à des « Conditions générales de la Société » non identifiées (Z-22). Le moment du prototype de fenêtre et le délai d'attente des résultats d'essai avant de généraliser ne sont pas fixés (Z-28).

L'unité d'hémodialyse du bassin 16

L'unité de ventilation qui dessert l'hémodialyse et le laboratoire, posée sur la toiture du basilaire nord au pied de la tour, est conservée en place et en fonction ; ses conduits qui traversent le parement sont enlevés et relocalisés temporairement, puis remplacés, et la passerelle d'accès en aluminium est enlevée avant la modification des conduits et réinstallée après (Z-29). Ce qui manque est précisément ce dont l'entrepreneur aura besoin : le tracé et la forme des conduits temporaires et définitifs — selon GLCRM, probablement au même endroit dans une forme différente —, la séquence de basculement, et les fenêtres d'interruption au-delà de « une journée, un conduit à la fois, dimanche seulement, en dehors de la période estivale ». WSP doit définir la nature complète de ces interventions ; ses documents ne sont pas terminés.

Les renvois vers des documents absents

Le registre recense 41 renvois explicites d'un document vers un autre (R-01 à R-41). Une bonne part aboutit à un document présent mais muet sur le sujet — le devis renvoie l'horaire au contrat, qui n'en a pas ; il renvoie les mesures PCI au contrat, qui n'en contient aucune. Une autre part aboutit à un document absent : devis de mise en service et ses annexes, annexes J et DA.7 du devis, rapports

d'expertise en matières dangereuses, devis de structure, tableau des persiennes de WSP, onglet saisonnier du tableau du CISSS, feuille G003, règlement de stationnement de l'hôpital, procédures internes de cadenassage et d'évacuation, dessins d'archives de 1972. Le reste renvoie à des décisions de l'établissement qui sont encore à obtenir — coordination des accès, du débarcadère, de la marquise et de la zone IRM.

03 — Le plan de phasage proposé

Hôpital de Chandler, réfection de l'enveloppe · CISSS de la Gaspésie · AOC-077221 · dossier GLCRM R-657-24
Version lisible du 5 octobre 2026. Les fiches complètes, les matrices phase par système, les diagrammes et la liste des 719 contraintes par phase restent dans la version de référence (03-phasage).

Le phasage proposé suit l'ordre du plan clé des architectes — préalables, basilaire est, tour, basilaires nord, ouest et sud, clôture —, mais presque rien de cet ordre n'est écrit. Une douzaine de séquences seulement sont imposées par un texte ; tout le reste est une lecture des plans ou un choix d'ordonnancement, présenté comme tel avec ses variantes. Sept conflits ne peuvent pas être tranchés à partir des documents et attendent une décision des architectes, de WSP ou du CISSS.

Le document ne propose aucune durée. Le devis confie le phasage détaillé à l'entrepreneur général, les calendriers ne lient ni le CISSS ni les professionnels, et les durées de ± 5 , ± 8 et ± 4 mois du plan clé sont rapportées comme indications des architectes, non comme hypothèses.

Ce qui est écrit, et le reste

Les seules séquences que les documents imposent tiennent en peu de lignes, mais elles structurent tout.

Le devis exige que les travaux préparatoires et temporaires des systèmes existants soient faits **avant** la démolition, que les piquages sur les réseaux existants précèdent le début des travaux, et que les anomalies de chaque phase soient corrigées avant la suivante (AR-DEV-058, AR-DEV-030, AR-DEV-275). Il interdit de passer des installations temporaires de sécurité aux installations permanentes avant l'achèvement substantiel (AR-DEV-170). La structure impose, sur chaque façade, l'enchaînement démolition, relevé complet, coordination de l'alignement, fabrication, avec un point d'arrêt après le retrait des revêtements et un autre sur l'acier avant recouvrement (ST-030, ST-011, ST-018).

Pour les fenêtres, les plans d'architecture exigent que les fenêtres existantes restent en place « jusqu'à ce que les travaux par l'extérieur soient complétés », un plexiglas scellé dès le retrait — un bâti isolé de novembre à avril —, et la pose du thermos et de la finition le même jour que le retrait du plexiglas (AR-PLN-040 à 044). Le remplacement se fait en deux étapes dans la tour, en trois au rez-de-chaussée en blocs de béton, en deux pour les colombages de l'IRM et du niveau 100, et la première fenêtre posée sert de prototype en présence de l'architecte (AR-PLN-046 à 050).

Côté électromécanique, les plans de WSP fixent cinq préalables : conduits temporaires avant de démanteler la prise d'air du bloc opératoire (ME-042 à 045) ; conduits de l'hémodialyse et du laboratoire relocalisés temporairement avant la démolition, avec des coupures d'une journée, un conduit à la fois, le dimanche hors période estivale (ME-049 à 051) ; prise d'air médical temporaire sur la façade ouest pendant les travaux de la façade nord, réinstallée après le revêtement nord (ME-065 à 067) ; événements des autoclaves relocalisés avant le début de la façade ouest (ME-075) ; conduit de la hotte de médecine

nucléaire modifié sur toute la hauteur de la tour, avec un arrêt du vendredi au dimanche (ME-118, ME-119). Enfin, la procédure de fin de travaux PCI fixe l'ordre fermeture des plafonds, nettoyage, filtration, diffuseurs, et n'autorise le démantèlement des enceintes qu'après approbation (AR-DEV-243 à 245).

Ce qui n'est pas écrit est signalé partout de la même façon : [lecture] pour ce qui est lu sur un plan sans phrase correspondante, [choix] pour une décision d'ordonnancement que nous proposons, [à confirmer] pour ce que les documents ne fixent pas.

Deux découpages qui ne se recouvrent pas

Le dossier contient deux logiques de phasage sans lien entre elles, et nous les avons développées toutes les deux.

Le **découpage A** suit le plan clé de la feuille 010 : trois phases par partie de bâtiment, lues sur les couleurs — basilaire est en phase 1 (zones D, E, F), tour en phase 2 (zone A), basilaires nord, ouest et sud en phase 3 (zones B, J, K, I, H, G), archives et oncologie 2023 non touchées (zones C et L). Aucune phrase des plans n'écrit cette correspondance ; c'est une lecture à faire valider par les architectes.

Le **découpage B** suit le tableau des contraintes du CISSS : une seule « phase 1 », découpée en sous-phases par niveau — A pour le rez-de-chaussée, B pour le niveau 1 et le sous-sol, C pour la tour —, avec les étapes de fenêtres « plexiglass », « thermos » et « cadrage et toile », une classe PCI et un horaire par ligne.

Les deux ne peuvent pas porter le même travail. Le découpage B est horizontal, par niveau, alors que l'échafaudage, la démolition de l'enveloppe et la structure sont verticaux, par façade. Il ne peut donc porter que la partie intérieure du travail — fenêtres, volets, structure en entreplafond, accès — et laisse l'extérieur à ordonner par façade. C'est le premier des conflits exposés plus bas.

Le cadre commun

La phase 0 regroupe tout ce qui doit exister avant le premier travail sur l'enveloppe, soit 112 contraintes : autorisation de débiter après assurances et garanties, réunion d'ordonnancement au plus tard dix jours ouvrables après l'attribution, cinq calendriers à remettre dans des délais différents, plan de sécurité incendie approuvé par le CISSS, l'établissement et le service incendie, méthodologie PCI et plan des cloisons pour chaque phase, instrumentation du bruit et des vibrations installée avant le début, clôtures et barrières selon les phasages, séparation des accès du chantier et de l'hôpital, piquages sur les réseaux. Elle exige aussi que les plans soient émis pour construction : ceux du dossier sont pour soumission.

Les contraintes transversales — 497 dans le découpage A — valent pendant toutes les phases et ne sont pas répétées dans chaque fiche : préavis de 48 heures avant toute interruption de service, calendrier hebdomadaire remis le jeudi matin, commissionnaires à raison d'un pour cinq travailleurs dans les secteurs hospitaliers, livraisons entre 9 h et 15 h, pression négative et sas en zone de travaux, séparation coupe-feu d'une heure jusqu'à la dalle, permis de travail à chaud par quart, arrêt immédiat en présence d'amiante, issues et chemins d'évacuation maintenus sur 1650 mm, seuils de température des matériaux.

Chaque façade suit six étapes types, déduites des seules séquences écrites et reprises dans les deux cahiers graphiques :

- **E1 — Préparation** : classification PCI de l'intervention, cloisons, sas et pression négative, toile sur l'échafaudage, contournements électromécaniques de la façade, plan d'action pour les issues touchées.
- **E2 — Démolition de l'enveloppe** : retrait des revêtements, persiennes entreposées, équipements muraux démontés, fenêtres existantes maintenues.
- **E3 — Relevé et structure** : point d'arrêt, relevé complet, validation des dimensions avant fabrication, renforts et réparations de béton à 10 °C ou plus.
- **E4 — Enveloppe neuve** : pare-air, compartimentation, isolant, revêtement, solins, essais in situ.
- **E5 — Fenêtres** : plexiglas ou bâti isolé, puis thermos et finition le même jour.
- **E6 — Remise en service** : réinstallation des équipements, essais, désinfection terminale, correction des anomalies avant la phase suivante.

Placer E5 après E4 repose sur une lecture de « travaux par l'extérieur » comme la réfection complète de la façade. Une autre lecture est possible — l'étape extérieure de chaque fenêtre, que les détails nomment justement « travaux par l'extérieur » — et elle permettrait de retirer les fenêtres bien plus tôt. Les documents ne tranchent pas ; c'est aux architectes de le faire.

La phase 4 est la clôture : essais intégrés de l'alarme incendie, équilibrage, filtres remplacés avant la réception provisoire, mise en service avec préavis de 21 et 14 jours, deuxième certification de l'air médical, manuels deux semaines avant la réception, nettoyage final et contrôle de la qualité de l'air avant de rouvrir un service, réception avec inspection dans les dix jours ouvrables.

Découpage A — par secteurs du plan clé

Phase 1 — Basilaire est

Le basilaire est regroupe l'administration au niveau 100, les cliniques externes et l'oncologie de 1974 au rez-de-chaussée, et l'IRM. On y refait l'enveloppe sur deux niveaux, les bandes de toiture périmétriques et la compartimentation, avec des fenêtres en trois étapes au rez-de-chaussée en blocs et en deux étapes pour l'IRM et le niveau 100.

Deux sujets y pèsent. L'IRM d'abord : aucun élément ni entreposage métallique dans sa zone quand l'appareil est en service, porte et unité mobile coordonnées avec l'établissement, entreplafond libéré avant les volets coupe-feu des locaux R16, R34 et R36. Le local R-22 ensuite, où des renforts de colonnes en entreplafond sont classés IV, avec des conduits électriques à relocaliser avant : WSP le situe au « secteur IRM », ce qui le rattache à la phase 1, mais le tableau du CISSS le place dans la zone des archives, que le plan clé déclare non touchée. Les bi-blocs de la façade est s'y ajoutent, dont celui de la salle des serveurs, qu'on ne peut arrêter que brièvement, en semaine, hors période estivale.

Si la phase 1 est la première exécutée, c'est là que se fait le prototype de fenêtre et de mur-rideau.

Phase 2 — La tour, face par face

La tour porte les chambres, sur les niveaux 200 à 400. Ses fenêtres se remplacent en deux étapes, et le tableau du CISSS classe ses étapes « cadrage et toile » en classe III, horaire « J ». Aucun texte n'impose l'ordre des quatre faces ; deux règles seulement le contraignent : les conduits temporaires de l'hémodialyse précèdent la démolition des faces nord et ouest du niveau 200, et le conduit de médecine nucléaire est modifié « afin de permettre » les travaux de façade. Nous retenons nord, est, sud, ouest [choix] ; toute permutation qui respecte ces deux règles est admissible.

La **face nord** porte l'unité de ventilation de l'hémodialyse et du laboratoire, posée sur la toiture du basilaire nord (bassin 16) : unité conservée en fonction, conduits relocalisés temporairement avant la démolition puis remplacés, passerelle enlevée avant la modification des conduits et réinstallée après, coupures d'une journée un conduit à la fois, le dimanche, hors période estivale. Le tracé des conduits temporaires et la séquence de basculement restent à écrire par WSP (Z-29). La même face porte la chambre à pression négative 216, dont le conduit d'évacuation est prolongé hors des échafaudages.

La **face est** porte le conduit de la hotte de médecine nucléaire, modifié sur toute la hauteur avec des supports temporaires et un arrêt du vendredi au dimanche. La **face sud** porte la chambre à pression négative 307, qui ne se démantèle que lorsqu'elle est inoccupée, avec un conduit prolongé hors des échafaudages. La **face ouest** porte la prise d'air frais du bloc opératoire, maintenue en fonction par deux conduits temporaires de 900 × 900 mm raccordés au plénum sous le soffite, en deux étapes ; le nouveau conduit s'installe après la fin du revêtement, et les temporaires restent en place jusqu'à sa mise en service.

Phase 3 — Basilaires nord, ouest et sud

Aucun texte n'écrit l'ordre de ces trois façades. Les plans de WSP fixent seulement que la prise d'air médical temporaire se pose « sur la façade ouest pour permettre les travaux de revêtement sur la façade nord » et se réinstalle après le revêtement nord. Nous en déduisons nord avant ouest [lecture] — c'est la seule façon de ne pas percer un revêtement ouest neuf pour une installation temporaire —, sans que la simultanéité soit exclue. La façade sud n'est liée aux deux autres par aucun texte.

La **façade nord** porte la nouvelle issue extérieure permanente du laboratoire, en classe IV, que l'escalier no 7 des plans de structure est vraisemblablement [à confirmer] ; la sortie d'air et les évacuations du laboratoire, maintenues par des conduits temporaires ; et la centrale d'air médical, qui fonctionne 24 heures sur 24 et dont la prise d'air est relocalisée temporairement sur la façade ouest avec un boîtier HEPA, avec une première certification à la relocalisation. La toiture « nord-ouest » où se trouve la centrale n'est pas rattachée par écrit à la tour ou au basilaire.

La **façade ouest** porte les événements de vapeur des autoclaves, à relocaliser avant son début de nuit ou le matin avant 10 h, avec des tuyauteries temporaires prolongées sur la toiture jusqu'au coin sud-ouest ; les câbles chauffants, à reprendre hors de la période hivernale ; et la réinstallation finale de la prise d'air médical. Quatre systèmes qui ne s'arrêtent jamais — bloc opératoire, autoclaves, air médical, chaufferie — se retrouvent ainsi sur la même face.

La **façade sud** porte l'entrée des ambulances et l'entrée principale. Les gicleurs du quai des ambulances sont mis hors service par zone en deux coupures de deux heures, avec obturation et récupération du glycol ; l'entrée des ambulances passe par deux configurations successives et l'entrée principale par trois, chacune coordonnée avec l'établissement et annoncée trois semaines avant tout déplacement de voie. S'y ajoutent l'enseigne AMBULANCE, la caméra de l'urgence, la persienne de l'unité UT-2 de la chirurgie d'un jour, à démanteler lors d'une coupure rapide de nuit ou de fin de semaine, et le bi-bloc de la salle d'observation, réinstallé sur le garde-corps modifié. Les documents placent pourtant la zone d'ambulance tantôt au sud (WSP), tantôt au nord (une note des plans d'architecture) : la localisation est à confirmer.

L'ordre de référence et ses variantes

L'ordre de référence est 0, 1, 2, 3, 4, avec la façade nord avant l'ouest. Regrouper les deux phases de basiliaires avant la tour (0, 1, 3, 2, 4) est admissible, aucun texte ne liant la tour aux basiliaires ; commencer par la tour (0, 2, 1, 3, 4) l'est aussi, le prototype se faisant alors dans la tour. Traiter l'ouest avant le nord n'est pas retenu en l'état : la prise d'air temporaire de l'air médical percerait un revêtement ouest neuf, sauf si WSP propose un autre emplacement. Pour la nouvelle issue, deux options restent ouvertes : la construire dès la phase 0, pour pouvoir condamner une issue existante sans réduire le nombre d'issues, ou en séquence avec la façade nord, à condition qu'aucune issue existante ne soit mise hors service avant.

Découpage B — par niveaux du tableau du CISSS

Le rez-de-chaussée (sous-phases A.1 à A.7) commence par le maintien des accès extérieurs — marchandises, entrée principale, cliniques externes, ambulances, sonnette d'urgence, roulotte IRM —, enchaîne les trois étapes de fenêtres sur tous les locaux, et loge en A.6 les volets coupe-feu, la structure du local R-22 et les travaux bruyants. Le niveau 1 et le sous-sol (B.1.2 à B.2.2) regroupent la toile d'échafaudage, les prises d'air du service alimentaire en classe IV, la nouvelle issue du laboratoire et les étapes de fenêtres du niveau 1. La tour (C.2, C.4, C.5) ne porte que l'étape « cadrage et toile » de chaque niveau, en classe III, horaire « J ».

Le tableau n'énonce aucune dépendance : l'ordre de ses sous-phases est celui de leurs numéros [lecture]. Plusieurs étapes manquent — aucun plexiglas au niveau 1 ni dans la tour, aucune sous-phase C.1, C.3 ou B.1.1 —, et quatre lignes n'ont ni phase ni sous-phase.

Les systèmes critiques et leurs fenêtres de coupure

Ce sont les seules coupures que les documents autorisent ; partout ailleurs, les systèmes marqués « à garder en fonction » restent en service.

Système	Où	Fenêtre écrite	Phase (A)
Ventilation de l'hémodialyse et du laboratoire	Tour, face nord, niveau 200	Une journée, un conduit à la fois, dimanche, hors période estivale	2.N

Système	Où	Fenêtre écrite	Phase (A)
Bi-bloc de la salle de traitement d'eau 203 (hémodialyse)	Façade est selon le tableau D5	Courte, en semaine, hors période estivale	2
Bi-bloc de la salle des serveurs	Rez-de-chaussée, est	Courte, en semaine, hors période estivale	1
Prise d'air du bloc opératoire	Face ouest de la tour	Nuit ou fin de semaine, volets fermés	2.O
Hotte de médecine nucléaire	Tour, face est	Vendredi au dimanche	2.E
Chambre à pression négative 307	Tour, face sud	Seulement si la chambre est inoccupée	2.S
Soins intensifs, chambre 315	Tour, nord selon le tableau D5	Nuit ou jour, si aucune chambre n'est occupée	2
Événements des autoclaves	Façade ouest	Nuit ou le matin avant 10 h	3.O
Unité UT-2, chirurgie d'un jour	Façade sud	Coupure rapide, nuit ou fin de semaine	3.S
Gicleurs du quai des ambulances	Façade sud	Deux coupures de 2 h	3.S

Une exception reste à trancher par WSP : la caméra de l'urgence est déposée temporairement selon les plans, alors que le tableau de coordination écrit « Aucun arrêt ».

Sept conflits que les documents ne tranchent pas

K1 — Secteurs contre niveaux. Le tableau du CISSS prévoit le plexiglas de « tous les locaux » du rez-de-chaussée en une seule sous-phase, sur les zones E et H. Or la zone E est en phase 1 du plan clé et la zone H en phase 3. Si les fenêtres ne peuvent être retirées qu'une fois les façades refaites, cette sous-phase attend la fin de la phase 3, ou doit être scindée par secteur. Quatre issues sont possibles : scinder chaque sous-phase du CISSS par secteur du plan clé, ce qui demande une nouvelle émission du tableau ; refaire l'extérieur des deux basiliaires avant toute étape de fenêtres ; faire préciser par les architectes la portée de « travaux par l'extérieur », dont la lecture étroite lève l'essentiel du conflit ; ou faire confirmer que les sous-phases du CISSS n'ont pas de valeur d'ordre.

K2 — L'ordre des façades nord et ouest. Nord avant ouest est une lecture, pas un texte. La façade ouest porte en même temps les conduits temporaires du bloc opératoire, les événements relocalisés des autoclaves, la prise temporaire de l'air médical et les événements de la chaufferie. La seule façon de libérer cet ordre serait que WSP propose un autre emplacement temporaire pour la prise d'air médical.

K3 — Les saisons. Les travaux d'enveloppe sont contraints l'hiver — béton à 10 °C, maçonnerie, couverture, scellants —, alors que les coupures des unités critiques sont interdites l'été. L'hémodialyse et les serveurs doivent donc placer leurs coupures hors été et leurs travaux d'enveloppe hors gel. Le contrat ne comptait que deux hivers ; avec le calendrier de travail GLCRM, de janvier 2027 à décembre 2028, la période couvre deux étés complets et trois périodes de novembre à avril, la première et la dernière partielles. Avec la définition de travail de la période estivale (mi-juin à mi-août), une piste se

dessine : coupures critiques à l'automne ou au printemps, enveloppe à la belle saison, étapes intérieures des fenêtres l'hiver derrière un bâti isolé — ou des enceintes chauffées pour couler et maçonner l'hiver, au prix d'une surveillance hors heures. Les dates restent à confirmer avec le CISSS.

K4 — La nouvelle issue. Si le nouvel escalier sert à compenser une issue condamnée pendant les façades, il doit précéder cette condamnation ; s'il n'est qu'un ajout, il peut suivre. Les documents exigent deux issues minimum sans réduction de la capacité d'évacuation, sans dire lequel des deux cas s'applique. Un escalier d'issue temporaire à chaque issue condamnée reste possible, mais le devis interdit de passer des installations temporaires de sécurité aux permanentes avant l'achèvement substantiel : à faire confirmer pour un escalier.

K5 — Le régime PCI. Les fiches reprennent les classes du tableau du CISSS telles qu'écrites ; si la matrice de la procédure de 2017 s'applique, plusieurs activités montent d'une classe, avec sas, pression négative et équipe pluridisciplinaire obligatoires. Appliquer la classe la plus sévère des deux sources est conforme à la règle de primauté du devis ; obtenir du CISSS de la Gaspésie sa propre procédure et un tableau reclassé l'est davantage.

K6 — Les secteurs « non touchés ». Des activités en classe IV (local R-22) et des étapes de fenêtres (zone L) sont inscrites dans des secteurs que le plan clé exclut. Soit les lettres du tableau du CISSS désignent l'adjacence, soit le plan clé omet des travaux intérieurs ; l'un des deux documents est à corriger.

K7 — Trois numérotations « phase 1, 2, 3 ». Le plan clé, la feuille 002 et le tableau du CISSS emploient les mêmes chiffres sans lien. Dans nos documents, les configurations de la feuille 002 sont des états successifs de la façade sud, jamais des phases globales. À faire confirmer.

Ce que le CISSS doit valider

Les documents exigent l'approbation ou la présence du CISSS à chaque étape charnière : calendrier d'exécution et calendrier d'arrêt des installations dès la phase 0, puis à chaque mise à jour ; chaque interruption de service, avec préavis de 48 heures et inscription au calendrier du jeudi ; plan de sécurité incendie, avant le démarrage et à chaque mise hors service de gicleurs ; méthodologie PCI, emplacement des cloisons par phase, préparation des lieux avant chaque zone et nettoyage avant le démantèlement des enceintes ; chaque changement de configuration des accès extérieurs ; chaque coupure d'une unité critique dans sa fenêtre écrite ; l'inoccupation de la chambre 307 — celle de la chambre 216 n'est pas exigée par écrit, mais le tableau D5 demande d'en valider la fréquence d'utilisation ; les inspections et les deux certifications de l'air médical ; puis la mise en service, la formation et la réception.

Ce qui reste à localiser

Une vingtaine de cas ne peuvent pas être rattachés à une phase avec certitude, faute d'une localisation écrite. Six sont non déterminables dans le découpage A : volets coupe-feu du sous-sol, coussin du quai d'embarquement, évacuation de l'atelier de menuiserie, antenne au toit, persienne de l'échangeur de la roulotte IRM et entrée des marchandises. Les autres sont rattachées sous réserve : prise d'air du bloc

opératoire, événements des autoclaves et câbles chauffants, écrits « façade ouest » sans dire si c'est la tour ou le basilaire ; centrale d'air médical à la « toiture nord-ouest » ; soffite du porte-à-faux ; chambre 315 et salle 203, dont la façade n'est donnée que par le code de ligne du tableau D5 ; zone d'ambulance, écrite au sud par WSP et au nord par les architectes ; mur de fondation ; prototype, qui dépend de la première phase exécutée.

04 — La vérification adverse du phasage

Hôpital de Chandler, réfection de l'enveloppe · CISSS de la Gaspésie · AOC-077221 · dossier GLCRM R-657-24
Version lisible du 5 octobre 2026. Le relevé constat par constat, le journal des corrections et la table de couverture des 719 contraintes restent dans la version de référence (04-verification).

Le plan de phasage a été relu contre le registre par trois vérificateurs qui ne l'avaient pas rédigé : les 719 contraintes y sont toutes traitées, une seule violation a été trouvée et corrigée, et 38 affirmations qui n'étaient pas sourcées ou qui faisaient dire à une contrainte plus qu'elle ne dit ont été corrigées ou signalées. Plus rien dans le phasage ne prescrit ce que le registre interdit. Ce qui reste ouvert, ce sont neuf décisions qui appartiennent aux émetteurs des documents.

Comment on a vérifié

Chaque passe partait d'un angle différent, avec le registre pour seule source admise.

La première cherchait les **violations** : pour chaque fiche de phase, chaque variante et chaque case des matrices, une interdiction, une fenêtre horaire, un préavis ou un préalable du registre s'y oppose-t-il, et chaque identifiant cité dit-il ce qu'on lui fait dire ? La deuxième traquait les **hypothèses non sourcées** : pour chaque affirmation factuelle du phasage — localisation, appartenance d'une zone à une phase, ordre, classe PCI, horaire —, une source est-elle citée, dit-elle exactement cela, et le marqueur de lecture ou de choix est-il présent quand il le faut ? La troisième reprenait les **affectations** une à une : pour chacune des 719 contraintes, la phase attribuée est-elle justifiée par sa propre ligne du registre ?

Deux contrôles automatiques complétaient le tout : chaque identifiant du registre est-il cité dans le phasage, et les listes des fiches concordent-elles avec l'affectation ? Les constats des trois passes ont été contre-vérifiés un par un contre la ligne citée avant d'être retenus ; quelques-uns ont été écartés ou requalifiés, avec motif.

Ce qu'on a trouvé

Couverture : complète. Les 719 contraintes sont citées dans le phasage, 339 dans au moins une fiche de phase et 380 dans le tableau des contraintes transversales, qui valent à l'identique dans toutes les phases. Aucun identifiant cité n'est inexistant.

Une violation, corrigée. Le diagramme du découpage par niveaux dessinait la toile d'échafaudage après l'achèvement des façades, alors que le tableau du CISSS l'exige « jusqu'au moment de la pose des membranes pare-intempéries » — donc avant. Aucune fiche de phase ne prescrivait de coupure, d'ordre ou de mesure contraire au registre.

Trois séquences présentées comme écrites alors qu'elles étaient déduites. L'ordre nord avant ouest, que les plans de WSP ne fixent pas — ils situent seulement une prise d'air temporaire ; l'achèvement des façades avant le retrait des fenêtres, qui dépend de la portée non tranchée de «

travaux par l'extérieur » ; l'antériorité de la modification du conduit de médecine nucléaire, écrite « afin de permettre » et non « avant ». Les trois restent dans le phasage comme lectures, avec la lecture alternative.

Quatre préalables écrits omis, ajoutés : la prolongation temporaire du conduit de la chambre 307, la fenêtre « nuit ou jour si aucune chambre n'est occupée » de la chambre 315, la première certification de l'air médical dès sa relocalisation, et le préavis de trois semaines avant tout déplacement d'une voie d'accès.

Des hypothèses non sourcées. La plus grande part tenait à des identifiants cités à l'appui d'une affirmation qu'ils ne contiennent pas : on attribuait le phasage à l'entrepreneur sur la foi de deux contraintes qui ne le disent pas ; on écrivait « accès unique » là où le devis ne dit pas « unique » ; on rattachait le local R-22 à la phase 1 par une « adjacence » écrite nulle part, alors que WSP le situe au secteur de l'IRM. D'autres étaient des marqueurs manquants : les zones du laboratoire et de l'urgence rattachées aux façades nord et sud par simple lecture du plan clé, l'escalier no 7 présenté comme la nouvelle issue sans réserve, la centrale d'air médical placée au basilaire alors que rien ne dit tour ou basilaire. Quelques-unes, enfin, étaient des extrapolations, comme un échafaudage « de quatre étages » appuyé sur les toitures du basilaire, ou une phrase qui déclarait « non écrit » le maintien de deux issues minimum alors que le devis l'écrit. Toutes ont été corrigées ou marquées.

Des affectations erronées. Douze contraintes étaient rangées dans la mauvaise phase, typiquement une obligation continue « pendant toute la durée des travaux » codée comme un préalable de phase 0, ou un code hérité du regroupement de deux lignes voisines. Quatre localisations ont été marquées non déterminables. Les règles d'affectation ont été corrigées à la source et les listes régénérées.

Défauts trouvés au passage dans le registre

Trois renvois orphelins vers des blocs de rapport qui n'existaient plus ont été remplacés par les citations du devis, et quatre lignes des plans d'architecture dont les colonnes étaient décalées ont été rétablies. La vérification a aussi fait apparaître une divergence de localisation que le registre ne signalait pas : la zone d'ambulance est écrite au sud par WSP et au nord par une note des plans d'architecture, et le détail de la feuille 002 ne porte aucune orientation. Elle est exposée dans le phasage sans être tranchée.

Ce qui reste ouvert

Ces neuf points ne peuvent pas être résolus à partir des documents ; ils attendent une décision de l'émetteur indiqué.

1. La portée de « travaux par l'extérieur » sur la feuille 505, qui commande l'articulation entre façades et fenêtres — architectes.
2. L'ordre des façades nord et ouest, et la localisation tour ou basilaire de la centrale d'air médical, de la prise d'air du bloc opératoire et des événements des autoclaves — WSP.
3. La localisation de la zone d'ambulance, sud ou nord, et l'orientation du détail 1 de la feuille 002 — architectes et WSP.

4. L'identité entre l'escalier no 7 et la nouvelle issue, et l'ordre entre la nouvelle issue et la condamnation d'une issue existante — architectes et structure.
5. Le régime PCI applicable, les classes attribuées au tableau, la signification des codes d'horaire « J », « S » et « J/S », et la définition de la période estivale — CISSS. GLCRM a depuis retenu une définition de travail, de la mi-juin à la mi-août, qui reste à confirmer.
6. Les secteurs déclarés non touchés où le tableau du CISSS place pourtant des activités — architectes et CISSS.
7. La caméra de l'urgence, « Aucun arrêt » au tableau de coordination mais déposée temporairement selon les plans — WSP.
8. Six contraintes dont la phase n'est pas déterminable faute de localisation écrite.
9. La nature exacte des interventions sur les conduits de l'unité d'hémodialyse du bassin 16 et la séquence de sa passerelle — WSP, dont les documents ne sont pas terminés.

Les compléments de septembre

Le 15 septembre, une question de GLCRM sur l'appareil de la toiture du bassin 16 a conduit à identifier l'unité de ventilation de l'hémodialyse et du laboratoire, posée sur la toiture du basilaire nord au pied de la tour. Les documents de WSP sont cohérents entre eux : unité conservée en place et en fonction, conduits relocalisés temporairement puis remplacés, passerelle enlevée puis réinstallée. Ce qui manque est consigné en zone d'ombre Z-29. Au passage, une note des plans d'architecture qu'on avait rattachée à cette unité s'est révélée viser un autre appareil — le bi-bloc de la salle d'observation, posé sur un garde-corps de la façade sud ; la ligne du registre a été corrigée et la contradiction qu'on avait ouverte retirée avant diffusion.

Le 17 septembre, le phasage a été repris en partant des élévations plutôt que du plan. L'exercice a repris les 93 lignes du tableau de coordination de WSP, ajouté huit appareils repérés sur les dessins sans aucune ligne au tableau, et écrit 54 verrous entre les appareils et les étapes d'architecture. Il a corrigé les documents antérieurs sur quatre points : trois correspondances entre repères d'élévation et façades, que les titres des dessins tranchent ; la chaîne d'axes lettrée, où l'axe D.1' est à 303 mm de D.1 et non à mi-chemin de D.2 ; les comptes de fenêtres de coupure par façade ; et le nombre de lignes bornées par une saison, qui passe de six à huit. Il a relevé seize défauts documentaires, présentés dans la note 05.

05 — Le phasage lu sur les élévations

Hôpital de Chandler, réfection de l'enveloppe · CISSS de la Gaspésie · AOC-077221 · dossier GLCRM R-657-24
Version lisible du 5 octobre 2026. Les appareils positionnés sur chaque élévation et les 54 verrous sont dans le cahier graphique (plan-phasage-elevations, 14 planches) ; le détail des correspondances et du calage reste dans la version de référence (05-phasage-elevations).

Lu façade par façade, le phasage change de nature : ce n'est plus l'architecture qui ordonne les travaux, c'est l'électromécanique. Les seules dépendances écrites entre façades viennent des appareils qu'il faut déplacer ou maintenir en fonction avant de démolir un parement, et la façade nord ne peut pas être traitée d'un seul tenant parce que son propre tableau exige l'été pour une intervention et l'exclut pour deux autres. Rien de cela n'était visible dans la vue en plan.

Pourquoi repartir des élévations

Le cahier en plan répond à « dans quel ordre traiter les zones ». Il ne répond pas à la question que se pose l'entrepreneur devant un mur : qu'est-ce que je dois décrocher, déplacer ou garder en fonction avant de démolir ce parement ? Or les documents qui y répondent sont organisés par façade, pas par zone. Le tableau de coordination des équipements électromécaniques de WSP l'écrit dans ses notes générales : chaque ligne porte une façade et un repère d'élévation, sous la forme N-F-V-005 — façade nord, élévation F, ventilation, ligne 5. Il suffisait de le lire en regard des élévations d'architecture.

Le tableau compte 93 lignes : 30 au sud, 25 à l'ouest, 23 au nord et 15 à l'est. Elles sont toutes reprises dans le cahier, chacune positionnée sur son élévation ou signalée comme non repérable quand le dessin ne la montre pas.

Trois correspondances tranchées

Le cahier en plan laissait ouverte la correspondance entre plusieurs repères d'élévation et leur façade. Les titres des dessins l'écrivent. Le repère C est une élévation ouest partielle et D une élévation est partielle : la décision qu'on comptait demander aux architectes n'a plus lieu d'être. Le repère H, qu'on avait lu « nord partielle » sur le plan clé de la feuille 011, s'intitule « élévation est partielle », et le tableau de WSP code ses quatre lignes à l'est — notre lecture du plan clé était fausse. Deux repères, J au sud et K à l'ouest, existent et n'apparaissent nulle part dans le cahier en plan.

Ce que chaque façade révèle

Les quatre façades comptent ensemble 101 appareils — les 93 lignes du tableau et huit appareils repérés sur les dessins sans aucune ligne — et 54 verrous entre ces appareils et les étapes d'architecture. Presque tous se jouent entre la préparation et la démolition : les contournements électromécaniques doivent être en place avant qu'on touche à l'enveloppe.

La façade nord compte 24 appareils et 16 verrous. Elle porte l'unité de ventilation de l'hémodialyse, conservée en place pendant que ses conduits sont relocalisés, et deux verrous inverses, où c'est l'architecture qui doit livrer : une alcôve dans le nouveau revêtement pour la sortie d'arrosage encastrée, et des trappes d'accès identiques aux existantes, sans lesquelles la mécanique du porte-à-faux devient inaccessible. Elle porte surtout un conflit saisonnier interne : le clavier de la porte de garage du quai des ambulances est écrit « en période estivale », l'unité d'hémodialyse « dimanche seulement, en dehors de la période estivale » et la déshumidification « sauf en période estivale ».

La façade est compte 15 appareils et 9 verrous. Un bandeau lumineux continu sous le parapet, sur la tour comme sur le basilaire, y est hors service pendant toute la durée des travaux du secteur traité : la longueur du tronçon attaqué d'un coup fixe directement l'étendue de façade laissée sans éclairage la nuit. Les deux coupures bornées à la semaine hors période estivale — le bi-bloc de traitement d'eau de l'hémodialyse et le câblage du bi-bloc de la salle des serveurs, deux locaux critiques — tombent au même endroit, entre les axes F et E au niveau 200 : une seule fenêtre peut servir aux deux.

La façade sud compte 33 appareils et 15 verrous, et presque tout s'y joue à l'ouest de l'axe 1. Treize appareils sont concentrés sous et autour de la marquise de l'entrée des ambulances, dans moins de six mètres : la seule ligne de protection incendie de tout le tableau (gicleurs mis hors service, glycol récupéré), l'enseigne AMBULANCE, l'unité bi-bloc du prélèvement d'urgence, les événements de vapeur de l'autoclave et de la chaufferie, et six appareils marqués non touchés. C'est le bout de façade le plus chargé du projet.

La façade ouest compte 29 appareils et 14 verrous, et porte les plus gros travaux temporaires du chantier : deux conduits de prise d'air frais de 900 × 900 mm desservant le bloc opératoire, montant du niveau 100 au niveau 300 entre les axes D.1' et D.2, à installer en plusieurs étapes avant de toucher au parement derrière le conduit existant. L'unité d'hémodialyse y est aussi repérée, alors que le tableau ne la porte qu'au nord : ses conduits traversent le parement des deux côtés de l'angle, et le nord et l'ouest ne peuvent pas être planifiés séparément sur ce point. On y trouve enfin le seul verrou hivernal du projet — le thermostat et le câble chauffant des conduits, « en dehors de la période hivernale », pour une durée écrite en mois — et un verrou inverse : le bi-bloc de la salle d'observation se réinstalle sur le garde-corps modifié, qui doit donc être posé avant.

Ce que les saisons commandent

Huit lignes du tableau sont bornées par une saison. Deux exigent l'été : le clavier de la porte de garage au nord (N-F-E-008) et la persienne du garage des ambulances à l'ouest (O-B-V-004). Quatre l'excluent : l'unité d'hémodialyse et la déshumidification au nord (N-F-V-005, N-F-P-002), le bi-bloc de traitement d'eau et celui de la salle des serveurs à l'est (E-G-V-003, E-G-E-006). Une se contredit elle-même au sud, « en dehors de la période estivale (quelques jours en été) » (S-A-V-001). La dernière exclut l'hiver à l'ouest (O-B-E-001).

GLCRM retient une période estivale de la mi-juin à la mi-août, approximativement du 24 juin au 15 août, et un calendrier de travaux de janvier 2027 à décembre 2028, après une installation de chantier en novembre 2026. Les deux sont des données de travail à confirmer avec le CISSS. Elles ouvrent deux

fenêtres estivales d'environ sept semaines et demie chacune, en 2027 et en 2028, là où l'échéancier écrit au contrat, du 31 août 2026 au 31 décembre 2027, n'en ouvrirait qu'une et reste de toute façon inapplicable en l'état.

La conséquence est directe pour la façade nord : elle se scinde en au moins deux passages, de part et d'autre d'une fenêtre estivale. Avec deux étés disponibles, c'est tenable ; avec un seul, ça ne l'était pas. La façade ouest, elle, est une façade de belle saison.

Ce que le tableau commande sur l'ordre des façades

Les seules dépendances écrites entre façades sont électromécaniques. La prise d'air médical temporaire se pose sur la façade ouest pour permettre le revêtement nord et se réinstalle après lui ; les conduits temporaires de l'hémodialyse précèdent la démolition au nord comme à l'ouest ; les événements des autoclaves, dessinés sur l'élévation sud, sont à relocaliser avant le début de la façade ouest ; le conduit de la hotte de médecine nucléaire est modifié pour permettre la façade est. Aucune de ces règles ne vient de l'architecture.

Zones de chantier et clôtures

Les plans ne montrent qu'une seule configuration de clôture pour tout le site, plus deux détails d'accès locaux à l'entrée des ambulances et à l'entrée principale. Le devis exige pourtant des barrières « selon les phasages », des cloisons anti-poussière « durant chaque phase » et un échafaudage choisi en fonction du phasage. Le plan de chantier par phase est donc un livrable de l'entrepreneur, pas une donnée de l'appel d'offres. Ni l'emprise d'échafaudage, ni la grue, ni l'entreposage, ni la roulotte, ni le conteneur à déchets ne sont dessinés, alors que le devis renvoie aux plans pour trouver le conteneur et exige des signaleurs aux barrières « identifiées aux plans ». Le devis place aussi le bureau de chantier dans un stationnement étagé que la feuille 001 ne montre pas.

La planche des zones de chantier par phase ne pourra être dessinée qu'une fois reliées les trois numérotations « phase 1, 2, 3 » du dossier — plan clé, feuille 002 et tableau du CISSS.

Seize défauts à faire lever

La lecture des élévations a fait apparaître seize défauts dans les documents de WSP et d'architecture.

Sept tiennent à des appareils réels sans ligne au tableau de coordination : l'unité d'hémodialyse et sa passerelle sur l'élévation ouest, le thermostat des câbles chauffants au sud, les événements de l'autoclave — dessinés au sud mais rattachés par écrit à l'ouest —, les événements de la chaufferie, dont la note en annonce trois et le dessin un seul, la persienne de prise d'air du service alimentaire à l'ouest, le sectionneur de thermopompe du repère D et l'enseigne « ambulance urgence » du repère E.

Quatre lignes du tableau disent autre chose que la note du dessin : le câblage du bi-bloc de la salle des serveurs, que le dessin accole à une autre unité ; deux persiennes de l'est « à relocaliser » au tableau et « à démanteler complètement » sur le dessin ; un support « mural » au tableau et « au toit » sur le

dessin ; une persienne de l'ouest « à relocaliser » au tableau et « à remplacer par une persienne moins large » sur le dessin.

Restent un doublon de code au tableau (deux lignes N-F-E-006), une élévation partielle sans aucun axe qui rend un appareil impossible à positionner, sept cibles identiques pour six lignes au sud, une zone grise au-dessus de la marquise des ambulances que rien ne permet d'identifier, et des numéros de persiennes P-01 à P-18 sans nomenclature retrouvée. Deux appariements demandent enfin le plan du niveau 100 : lequel des deux couples de luminaire et de lecteur dessert le laboratoire et lequel le bloc opératoire, et laquelle des deux persiennes de la roulotte d'IRM est l'échangeur.

Ce qui reste à faire

Obtenir du CISSS la confirmation de la période estivale et du calendrier de travaux, l'arbitrage du conflit de la façade nord et le sens de la ligne S-A-V-001. Faire lever par WSP les seize défauts, en commençant par le rattachement de l'unité d'hémodialyse côté ouest et les travaux de la façade sud sans ligne au tableau, et obtenir le tracé des conduits temporaires de l'hémodialyse avec leurs fenêtres d'interruption. Obtenir des architectes la correspondance entre les trois numérotations de phases, sans laquelle la planche des zones de chantier par phase ne peut pas être dessinée. Arbitrer enfin avec l'entrepreneur la longueur des tronçons traités d'un coup : c'est elle qui fixe la durée d'indisponibilité des 47 lignes du tableau marquées « toute la durée des travaux ».